

Espace de travail — Types de transport sanitaire

Objectif

Comprendre les principaux types de transport sanitaire et ne pas confondre :

- le cadre du transport ;
- qui prescrit ;
- qui organise ;
- qui paie ;
- quel véhicule est adapté.

1. Définition générale du transport sanitaire

Le transport sanitaire correspond au transport d'une personne malade, blessée ou parturiente pour des raisons de soins ou de diagnostic, avec des moyens adaptés à son état de santé.

Il peut être réalisé :

- sur prescription médicale ;
- dans le cadre de l'aide médicale urgente (AMU).

2. La PMT : Prescription Médicale de Transport

Définition

La **PMT** est le document médical qui justifie qu'un patient a besoin d'un transport pour raisons médicales.

À retenir

- Elle doit en principe être **faite avant le transport**.
- Elle précise le **motif médical** et le **mode de transport adapté**.
- Elle ne sert pas seulement à "avoir un bon de transport" : elle sert à **justifier médicalement** le choix du transport.

Le médecin choisit le mode de transport selon l'état du patient

Ambulance

Elle est indiquée si le patient a besoin :

- d'un **transport allongé ou semi-assis** ;
- d'un **brancardage ou portage** ;
- d'une **surveillance par une personne qualifiée** ;
- d'**oxygène** ;
- ou de **conditions d'asepsie**.

Transport assis professionnalisé (TAP)

Il concerne un patient pouvant voyager assis.

Il peut être réalisé par :

- **VSL** ;
- **taxi conventionné**.

Erreurs fréquentes

- Croire que le patient choisit librement le véhicule.
- Confondre confort et nécessité médicale.
- Penser qu'un simple rendez-vous justifie forcément une ambulance.

3. Les grands cadres de transport à connaître

A. Transport sur PMT

Définition

Transport prescrit par un médecin, hors urgence vitale immédiate, pour consultation, examen, hospitalisation, retour à domicile, dialyse, radiothérapie, rééducation, etc.

Exemples

- entrée à l'hôpital ;
- sortie d'hospitalisation ;
- séance de dialyse ;

- consultation spécialisée ;
- radiothérapie ;
- transfert médicalement justifié hors urgence SAMU.

Points clés

- il faut une **prescription médicale** ;
- le véhicule dépend de **l'état clinique du patient** ;
- l'ambulancier applique la prescription mais n'invente pas le cadre.

B. Transport en AMU

Définition

Le transport relève de l'**Aide Médicale Urgente** quand il s'inscrit dans une situation d'urgence régulée médicalement.

Repères

- décision du **SAMU / Centre 15** ;
- engagement de moyens adaptés ;
- possibilité de transport sanitaire urgent ;
- logique de réponse rapide et adaptée.

À retenir

En AMU, l'ambulancier agit **sous régulation médicale**.

Il n'auto-régule pas la situation.

Exemples

- détresse respiratoire ;
- douleur thoracique suspecte ;
- malaise grave ;
- urgence vitale ou potentiellement vitale.

C. TUPH : transport urgent préhospitalier

Définition simple

Le **transport urgent préhospitalier** correspond à une mission urgente avant l'hôpital, relevant d'une organisation départementale de la réponse ambulancière urgente.

Idée clé

C'est de l'urgent, organisé pour répondre vite, avec un cadre de garde et de coordination.

À retenir

- ce n'est pas un transport programmé ;
- ce n'est pas un simple trajet "rapide" ;
- c'est un transport urgent intégré à l'organisation de l'urgence.

D. Transport hospitalier sous article 80

Définition

L'**article 80** concerne certains transports de patients **déjà hospitalisés**.

Dans ce cadre, le transport n'est plus facturé comme un transport classique à l'Assurance Maladie du patient : il est à la charge de l'établissement concerné selon les règles prévues.

Idée centrale

Quand le patient est **déjà hospitalisé**, la logique change :

ce n'est plus seulement "un patient avec une PMT", c'est aussi un **patient relevant d'un établissement de santé**.

Principe général

L'établissement à l'origine de la prescription ou responsable selon la situation :

- **prescrit** ;
- **organise** ;
- **supporte la charge du transport**.

Cas classiques à connaître

- transport d'un patient déjà hospitalisé vers un autre établissement ;
- transfert provisoire pour examen ou soin ;
- aller-retour entre établissements dans le cadre de l'hospitalisation.

Attention

L'article 80 ne supprime pas le caractère sanitaire du transport.

Le transport reste médicalement justifié, mais la **facturation** et la **prise en charge** changent.

Piège fréquent

Confondre :

- **PMT** = justification médicale du transport ;
- **article 80** = règle de prise en charge pour certains patients déjà hospitalisés.

En clair :

un transport article 80 peut aussi nécessiter une prescription médicale, mais il n'est pas géré comme un transport "classique" de ville.

4. Les véhicules à distinguer

Ambulance

Pour les patients nécessitant :

- position allongée ou semi-assise ;
- surveillance ;
- portage/brancardage ;
- oxygène ;
- asepsie.

VSL

Pour les patients pouvant être transportés **assis**, sans nécessité de surveillance continue lourde, avec accompagnement professionnel.

Taxi conventionné

Pour certains **transports assis professionnalisés** si l'état du patient le permet.

Point examen

Le véhicule n'est pas choisi selon l'habitude, la préférence, ou la météo de l'âme.

Il est choisi selon **l'état du patient** et la **prescription**.

5. Tableau mémo ultra simple

Situation	Prescription	Organisation	Paielement / prise en charge	Exemple
PMT classique	Médecin	Selon le cadre habituel	Assurance Maladie si conditions remplies	Consultation, entrée, sortie
AMU	Régulation médicale / médecin	SAMU / Centre 15	Cadre urgence	Détresse vitale
TUPH	Cadre urgent régulé	Organisation territoriale urgente	Cadre transport urgent	Intervention urgente avant hôpital
Article 80	Oui, selon la situation	Établissement concerné	Établissement de santé	Patient déjà hospitalisé transféré

6. Différence essentielle entre PMT et article 80

PMT

Répond à la question :

“Pourquoi ce patient a-t-il besoin d'un transport médical et avec quel mode ?”

Article 80

Répond à la question :

“Quand le patient est déjà hospitalisé, qui prend en charge et facture ce transport ?”

Formule simple à retenir

- **PMT = justification médicale**
- **Article 80 = règle de financement / organisation pour certains patients hospitalisés**

7. Ce que l'ambulancier doit faire sur le terrain

- vérifier le cadre de la mission ;
- repérer si le patient est **hospitalisé ou non** ;
- vérifier la cohérence entre l'état du patient et le mode de transport ;
- transmettre correctement les informations ;
- ne pas sortir de son rôle.

Il ne doit pas

- modifier seul la prescription ;
- décider seul qu'un transport article 80 ne l'est pas ;
- choisir un véhicule par confort commercial ;
- confondre urgence ressentie et urgence régulée.

8. Exemples concrets

Exemple 1

Patient à domicile, convoqué pour radiothérapie, transport assis possible.

→ **PMT classique**

→ souvent **VSL ou taxi conventionné** selon prescription.

Exemple 2

Patient hospitalisé en médecine, envoyé dans un autre établissement pour un examen puis retour.

→ **transport lié à l'hospitalisation**

→ **article 80.**

Exemple 3

Patient à domicile avec détresse respiratoire, appel 15, envoi d'un moyen urgent.

→ **AMU**

→ transport urgent sous régulation médicale.

Exemple 4

Patient allongé, sous oxygène, nécessite surveillance pendant le trajet.

→ **ambulance**.

9. Phrase examen

« La PMT justifie médicalement le transport et son mode, tandis que l'article 80 concerne la prise en charge des transports de certains patients déjà hospitalisés. »

10. Astuce mémo

P-M-T

- Pourquoi transporter ?
- Mode de transport ?
- Trajet médicalement justifié

Art. 80

- patient **déjà hospitalisé**
- établissement **prescrit / organise / paie** selon la situation

11. Mini conclusion

Pour ne pas te tromper :

1. je regarde **l'état du patient** ;
2. je regarde **le cadre du transport** ;

3. je distingue **prescription médicale** et **règle de prise en charge** ;
4. je n'oublie jamais qu'un transport sanitaire, ce n'est pas juste un déplacement — c'est un acte encadré.